

회음부 요도루조성술은 음낭과 항문 사이의 회음부에 소변이 나오는 새로운 영구 개구부를 만드는 수술입니다. 요도가 너무 좁아지거나 손상되어 재건이 어려울 때 시행합니다. 수술 후에는 음경 끝 대신 이 개구부를 통해 앉아서 소변을 봅니다. 이 안내문은 수술 방법, 준비 사항, 예상 경과를 설명합니다.

이 수술에 대하여

요도 협착은 요도가 흉터 조직으로 좁아져 소변 흐름을 막는 상태입니다. 협착 부위가 길거나, 치료 후 재발하거나, 요도가 너무 손상된 경우, 집도의는 협착 뒤쪽의 **건강한 요도**를 회음부 피부로 끌어내어 봉합하여 넓고 지속적인 개구부를 만듭니다. 소변은 이 개구부를 통해 배출됩니다.

복잡한 요도 협착이나 반복 수술을 원하지 않는 분께 적합한 **신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어난** 방법입니다.

알아두어야 할 사항

가장 큰 변화는 새 개구부를 통해 **앉아서 소변을 본다**는 점입니다. 음경 끝으로는 더 이상 소변이 나오지 않습니다. 대부분의 남성은 잘 적응하며 만족도가 높습니다. **음경은 그대로 유지**되며 감각과 오르가즘은 보통 변하지 않고, 대부분 발기 기능도 유지됩니다(일부는 변화를 느낄 수 있습니다). 시간이 지나면 개구부가 **좁아질** 수 있으나, 작은 시술로 대개 다시 넓힐 수 있습니다.

용어 설명

요도

소변을 몸 밖으로 내보내는 관.

요도 협착

요도가 흉터 조직으로 좁아져 소변 흐름을 막는 상태.

회음부

음낭과 항문 사이의 부위로, 새 개구부가 만들어지는 곳.

회음부 요도루조성술

요도를 회음부의 새로운 영구 개구부로 연결하는 수술.

개구부(스토마)

소변이 몸 밖으로 나오는 새 구멍.

개구부 협착

새 구멍이 시간이 지나 좁아지는 것 — 보통 작은 시술로 교정 가능.

도뇨관

개구부가 아물 동안 1~2주간 유지되는 부드러운 관.

전신마취

수술 중 잠들어 통증을 느끼지 않도록 하는 마취.

아픈가요? 수술은 전신마취 또는 척추마취 하에 진행되므로 수술 중에는 아무것도 느끼지 않습니다. 이후 1~2주간 회음부에 부기, 멍, 통증이 있을 수 있으며 좌욕, 냉찜질, 진통제가 도움이 됩니다. 수술 중 도뇨관이 삽입됩니다. 당일 또는 하룻밤 입원 후 퇴원하는 경우가 많습니다.

준비 방법 (수술 전)

- 전신마취 또는 척추마취로 진행됩니다 — 금식과 복용 약물(항응고제 포함) 중단 등 수술 전 지시를 따르세요.
- 소변 검사로 감염 여부를 확인합니다(감염이 있으면 먼저 치료); 항생제가 투여됩니다. **금연**하세요 — 흡연은 회복을 늦춥니다.
- 수술 중 다리는 지지대에 올려집니다. **약 1~2주간의 도뇨관 유지**와 귀가 시 동반자를 미리 준비하세요.

다음 사항은 **미리 의료진에게 알려주세요**:

- 골반 방사선 치료 병력이 있는 경우 — 개구부가 좁아질 가능성이 높습니다
- 항응고제 복용 중이거나 현재 감염이 있는 경우

수술 과정

- 1 마취 후 다리를 지지대에 올리고 항생제를 투여합니다.
- 2 회음부 절개를 통해 협착 뒤쪽의 건강한 요도를 찾아 흉터 부위를 제거하거나 우회합니다.
- 3 건강한 요도를 피부로 끌어내어 넓은 개구부가 되도록 봉합하고, 도뇨관을 삽입한 뒤 상처를 닫습니다.

수술 후

- 1~2주간 회음부에 **부기, 멍, 통증**이 있습니다. 좌욕, 냉찜질, 진통제를 활용하고 해당 부위를 청결히 유지하세요.
- **도뇨관은 약 1~2주 후** 의료진이 제거합니다. 이후에는 새 개구부를 통해 **앉아서 소변**을 봅니다.
- 수 주간 **무거운 물건 들기, 힘주기, 자전거 타기, 성관계**를 삼가고, 해당 부위에 직접 앉는 것도 지시에 따라 피하세요.
- 시간이 지나 소변 줄기가 **약해지면** 개구부가 좁아진 것일 수 있습니다 — 의료진에게 알려주세요. 작은 시술로 재개통할 수 있습니다.

다음 증상이 있으면 의료진에게 연락하세요:

- 도뇨관이 빠지거나 소변이 나오지 않거나, 제거 후 **소변을 볼 수 없는** 경우
- 발열, 오한, 또는 상처 부위의 발적·통증·부기·분비물이 심해지는 경우
- 심한 출혈

기억할 세 가지

1. 회음부 요도루조성술은 요도가 너무 좁아지거나 손상되었을 때 회음부에 영구 개구부를 만드는 수술입니다. 이후에는 **앉아서 소변**을 봅니다.
2. 내구성이 뛰어나고 반복 수술을 피할 수 있습니다. **음경은 그대로 유지**되며 감각과 오르가즘은 보통 변하지 않고 대부분 발기 기능도 유지됩니다.
3. 도뇨관은 약 1~2주간 유지됩니다. 개구부는 시간이 지나 좁아질 수 있으니 소변 줄기가 약해지면 의료진에게 알려주세요. 발열, 심한 출혈, 소변 장애 시 즉시 연락하세요.